

Historial Clinico - P005

Psiquiatria - Dr. Francisco Morales Jimenez - Granada

1. Datos del paciente

ID Paciente	P005
NHC	NHC-2021-013905
Nombre completo	Laura Navarro Gutierrez
Sexo	Mujer
Fecha nacimiento	29/11/1994
Edad	31 anos
DNI	26.741.308-Z
Telefono	633 098 712
Municipio	Granada
Medico responsable	Dr. Francisco Morales Jimenez
Especialidad	Psiquiatria

2. Antecedentes personales

- Trastorno de estres postraumatico cronico (diagnostico 2019, CIE-10: F43.1)
- Trastorno de personalidad limite (diagnostico 2020, CIE-10: F60.3)
- Autolesiones no suicidas recurrentes (cortes superficiales en antebrazos y muslos), ultimo episodio hace 2 meses
- Dos tentativas autoliticas previas por sobreingesta medicamentosa (2018 y 2022)
- Trastorno de la conducta alimentaria no especificado, actualmente en remision parcial (atracones esporadicos)
- Anemia ferropenica cronica
- Alergia a metamizol

Antecedentes familiares: Madre: trastorno depresivo recurrente, tratamiento con ISRS. Padre: trastorno de personalidad antisocial (no diagnosticado formalmente; maltrato intrafamiliar documentado por servicios sociales). Separacion de los padres cuando la paciente tenia 8 anos, orden de alejamiento. Hermano mayor: trastorno por consumo de sustancias.

3. Historia clinica actual

Paciente de 31 anos con diagnostico de trastorno de estres postraumatico cronico secundario a maltrato fisico y psicologico intrafamiliar por parte del padre durante la infancia y preadolescencia (de los 5 a los 12 anos, momento en que se interpuso orden de alejamiento), y diagnostico comorbido de trastorno de personalidad limite. Los sintomas de TEPT incluyen flashbacks intrusivos recurrentes del maltrato (3-4 por semana, desencadenados por gritos, portazos o discusiones), pesadillas con contenido traumatico (4-5 noches/semana que le impiden volver a dormir), hipervigilancia constante en espacios publicos y especialmente en presencia de hombres desconocidos, respuesta de sobresalto exagerada ante ruidos fuertes y evitacion sistematica de situaciones que activan recuerdos traumaticos (no puede ver peliculas violentas, evita conflictos interpersonales a toda costa, cambia de acera si ve a un hombre que le recuerda a su padre). Presenta alteraciones cognitivas negativas: creencias persistentes sobre si misma ('soy culpable de lo que paso', 'no merezco que me quieran'), incapacidad para experimentar emociones positivas y distanciamiento emocional de personas cercanas. La inestabilidad afectiva propia del TLP se manifiesta con cambios rapidos e intensos del estado de animo (de la normalidad a la desesperacion en minutos), sentimientos cronicos de vacio, patron de relaciones interpersonales inestable con idealizacion y devaluacion alternantes (5 relaciones sentimentales en 4 anos, todas con rupturas conflictivas), e impulsividad en forma de atracones alimentarios y compras impulsivas. Las autolesiones (cortes superficiales con cuchilla en antebrazos y muslos) funcionan como mecanismo de regulacion emocional ante estados disociativos; lleva un registro y el ultimo episodio fue hace 2 meses. Las dos tentativas

autolíticas previas ocurrieron en contexto de rupturas sentimentales (2018: ingesta de 25 comprimidos de paracetamol 1g, requirió lavado gástrico y tratamiento con N-acetilcisteína; 2022: ingesta de 20 comprimidos de lorazepam 1 mg, requirió observación en urgencias 24h). Actualmente niega ideación autolítica activa pero reconoce pensamientos pasivos de muerte en momentos de crisis emocional intensa, con frecuencia semanal. Está en programa de terapia dialéctico-conductual (DBT) grupal desde hace 10 meses con mejoría parcial en tolerancia al malestar y regulación emocional. Trabaja como camarera a media jornada. Vive sola en piso compartido con una compañera. Red social reducida a dos amigas y su terapeuta. Relación distante pero estable con su madre.

4. Exploración

Aspecto general	Consciente, orientada. Vestimenta con mangas largas. Cicatrices lineales antiguas visibles en dorso de manos y antebrazos, en distintos estadios de cicatrización
Psicomotricidad	Normal. Sin agitación. Hipervigilancia: mira repetidamente hacia la puerta y se sobresalta con un ruido en el pasillo
Estado de ánimo	Disfórico con componente ansioso. Afecto labil: llanto en tres ocasiones durante la entrevista al abordar contenido traumático y al hablar de su padre
Pensamiento	Curso normal. Contenido con rumiaciones sobre experiencias traumáticas, ideas de culpa y autodesprecio ('yo provoqué que mi padre se enfadara'). Niega ideación autolítica activa actual
Sensopercepción	Refiere episodios disociativos (despersonalización y desrealización) en situaciones de estrés intenso, duración de minutos a una hora. No alucinaciones
Cognición	Atención disminuida por hipervigilancia. Concentración irregular. Memoria conservada excepto lagunas parciales en período traumático (6-12 años)
Regulación emocional	Intensidad emocional alta con tiempo de retorno a la línea base prolongado (horas). Identifica patrón de 'ola emocional' aprendido en DBT
Riesgo autolítico	Riesgo moderado-alto: dos tentativas previas, autolesiones recurrentes, ideación pasiva de muerte semanal. Factores protectores: terapia activa, amigas, trabajo. Sin plan actual
Peso / Talla / IMC	54 kg - 160 cm - 21,1 kg/m ²
Tensión arterial	106/66 mmHg
Frecuencia cardíaca	94 lpm, rítmica (taquicardia situacional por ansiedad)

5. Tratamiento actual

Farmaco	Posología
Sertralina 200 mg	1 comp. en desayuno (dosis máxima ISRS para TEPT)
Prazosina 3 mg	1 comp. en cena (reducción de pesadillas traumáticas)
Quetiapina 25 mg	1 comp. en cena si insomnio o agitación nocturna (uso a demanda, máximo 4 noches/semana)
Hidroxizina 25 mg	1 comp. si crisis de ansiedad aguda (alternativa a benzodiacepinas, contraindicadas)
Hierro oral 80 mg + Vit. C 250 mg	1 comp. en ayunas (anemia ferropénica)

6. Resultados de laboratorio

Parámetro	Resultado	Ref.	Estado	Previo
Hemograma	Hb 11,2 g/dL	12,0-16,0	Bajo	10,8 g/dL
Ferritina	15 ng/mL	20-200	Bajo	12 ng/mL

Hierro serico	48 mcg/dL	60-170	Bajo	42 mcg/dL
Transferrina sat.	14 %	20-50 %	Bajo	11 %
Vit. D	16 ng/mL	30-100	Bajo	14 ng/mL
TSH	2,6 mU/L	0,4-4,0	Normal	2,8 mU/L
Glucosa	84 mg/dL	70-110	Normal	88 mg/dL
Perfil hepatico	Normal	-	Normal	Normal
Cortisol (8h)	21,8 mcg/dL	6,0-18,0	Alto	-

7. Plan de actuacion

1. Mantener sertralina 200 mg (dosis maxima; no hay margen de aumento). Si respuesta insuficiente en 8 semanas, valorar potenciacion con prazosina o cambio a venlafaxina
2. Titular prazosina a 4 mg si pesadillas persisten con frecuencia > 3 noches/semana
3. Suplementacion: hierro oral 80 mg/dia con vitamina C hasta normalizacion de ferritina + vitamina D 2.000 UI/dia
4. Continuar programa DBT grupal semanal (Fase 1: estabilizacion y reduccion de conductas de riesgo)
5. Terapia individual quincenal: iniciar procesamiento traumatico con EMDR en Fase 2 (previsto para el proximo trimestre si se mantiene estabilidad)
6. Plan de seguridad actualizado: cadena de contacto (terapeuta > amiga Paula > Telefono de la Esperanza 717 003 717 > Urgencias 112), kit de crisis con habilidades TIPP
7. Contraindicacion expresa de benzodicepinas por riesgo en contexto de impulsividad, autolesiones y tentativas previas
8. Control analitico en 2 meses: hemograma, ferritina, hierro, vitamina D
9. Revision presencial en 4 semanas. Contacto telefonico intermedio en 2 semanas
10. Si crisis emocional con ideacion autolitica activa: acudir a Urgencias del Hospital Clinico San Cecilio

AVISO: Todos los datos de este documento son completamente ficticios. Generado para el TFG: Sistema RAG de apoyo en salud mental.